

İLK YARDIM

PROF.DR. NURSAN ÇINAR

İLK YARDIM NEDİR?

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilkyardım denir.

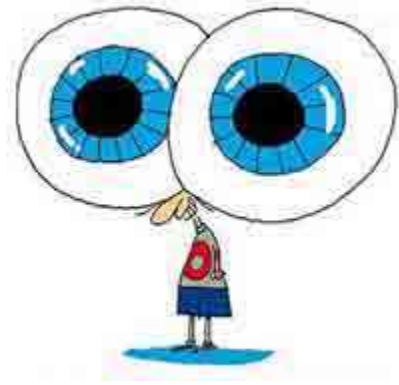
İLK YARDIM UYGULAMASINDA
KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ !!!

İLK YARDIMDA AMAÇ NEDİR?

- * Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,**
- * Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,**
- * Hasta veya yaralının durumunun, kötüleşmesini önlemek,**
- * İyileşmeyi kolaylaştırmak**

İLK YARDIMCI

- İlk yardım sertifikası almış kişiye **ilkyardımcı** denir.



İLK YARDIMCININ ÖZELLİKLERİ

- Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bunun için bir ilk yardımcıda aşağıdaki özelliklerin olması gerekmektedir:
- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmak,
- Önce kendi can güvenliğini korumak,
- Çevredeki kişileri organize edebilmek ve onlardan yararlanabilmek,

- Sakin, kendine güvenli ve pratik olmak
- Eldeki olanakları değerlendirebilmek
- iyi bir iletişim becerisine sahip olmak
- Olayı anında ve doğru olarak 112 acil yardım servisine haber vermek

112'nin Aranması Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

- 1. **Sakin olunmalı** ya da **sakin olan bir kişinin** araması sağlanmalı,
- 2. 112 tarafından sorulan sorulara **net cevaplar verilmeli,**
- 3. Adres verilirken, olay yerine yakın **cadde** ya da **çok bilinen bir yerin** adı verilmeli,
- 4. Hangi **numaradan** arandığı,

- 5. Hasta/yaralı **adı ve olayın tanımı**,
- 6. Hasta/yaralı **sayısı ve durumu**,
- 7. Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa **nasıl bir yardım verildiği** belirtilmeli,
- 8. 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon **kapatılmamalıdır.**

İLK YARDIMDA EĞİTİMİN ÖNEMİ

Ölümlerin ve kalıcı sakatlanmaların büyük çoğunluğu panik ve kargaşanın hakim olduğu ilk dakikalarda yanlış müdahale ve karga tulumba taşıma sırasında gerçekleşmektedir.

İLK YARDIMDA EĞİTİMİN ÖNEMİ

- Hasta / Yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlanmaları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım gereklidir.
- İlkyardımın doğru yapılabilmesi için de **İlkyardım Eğitimi** zorunludur.

ZAMANIN ÖNEMİ

“İlk yardımın çabuk doğru ve etkili yapılabilmesi önemlidir.”

- **KAZA SONRASI ÖLÜMLER :**
- **İLK 5 DAKİKA : % 10**
- **İLK 30 DAKİKA : % 55-60**

En etkili ilk Yardım, ilk 5 dakikada, En bilinçli ilk Yardım ise ilk yarım saatte yapılmaktadır.

İLETİŞİM

- Dakikalar içerisinde olay yerine eğitilmiş personelin gelmesi ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçecektir.

Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?



İLK YARDIMIN ÖZELLİKLERİ	ACİL BAKIMIN ÖZELLİKLERİ
Amaç kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesinin önlenmesidir.	Amaç, hasta/yaralıyı tedavi etmektir.
Hayatın kurtarılması esastır.	Tekrar eski sağlığına kavuşturmak esastır.
Olay yerinde uygulanır.	Genellikle sağlık kuruluşunda uygulanır.
İlk yardım konusunda eğitim almış herkes uygulayabilir.	Sağlık eğitimi görmüş sağlık personeli uygular.
Çevredeki araç gereçler kullanılır.	İlaç- tıbbi araç gereç kullanılır.
Geçici bir uygulamadır.	Esas tıbbi bakımdır.

İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?

İlk yardımın temel uygulamaları;

- 1. Koruma,
- 2. Bildirme,
- 3. Kurtarma (**K -B -K**) olarak ifade edilir.

- **KORUMA**

Ortam güvenliğini sağla. İkinci tehlikeyi önle.

- **BİLDİRME**

1-1-2'ye haber ver.

- **KURTARMA**

Eğitimde öğrendiklerini uygula.

BİLDİRME



KORUMA



KURTARMA

Yaşam Bulguları Nelerdir?

Yaşam bulgularının değerlendirilerek « **var ya da yok** » olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

«İLK DEĞERLENDİRME»

amasında hastanın yaşam bulguları yer alır.

YAŞAM BULGULARI

Bilinç

Solunum

Dolaşım

Vücut Isısı

- **Bilinç Durumu**
- **Normal bir kişi kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verir.**
- **Eğer dokunarak veya sesli uyarılara cevap vermiyorsa bilinç kaybı vardır.**

Bilinç kontrolü nasıl yapılır ?

Hasta veya yaralıya seslenerek yada hafifçe omzuna dokunarak "iyi misiniz?" diye sorularak bilinç kontrolü yapılır.

Solunum

- Normalde 1 dakikadaki solunum sayısı yetişkinlerde 16-24 /dk

Çocuklarda

- 0-1 yaş 26- 40 /dk
- 1-6 yaş 20-30 /dk
- 6-11yaş 18-24/dk
- 11 yaş dan sonra yetişkin düzeyindedir.

SOLUNUM

- **Bir nefes almak ve bir nefes vermek bir solunum olarak kabul edilir.**
- **30 saniye veya 15 saniye sayılır iki veya dört ile çarpılarak solunum sayısı bulunur.**

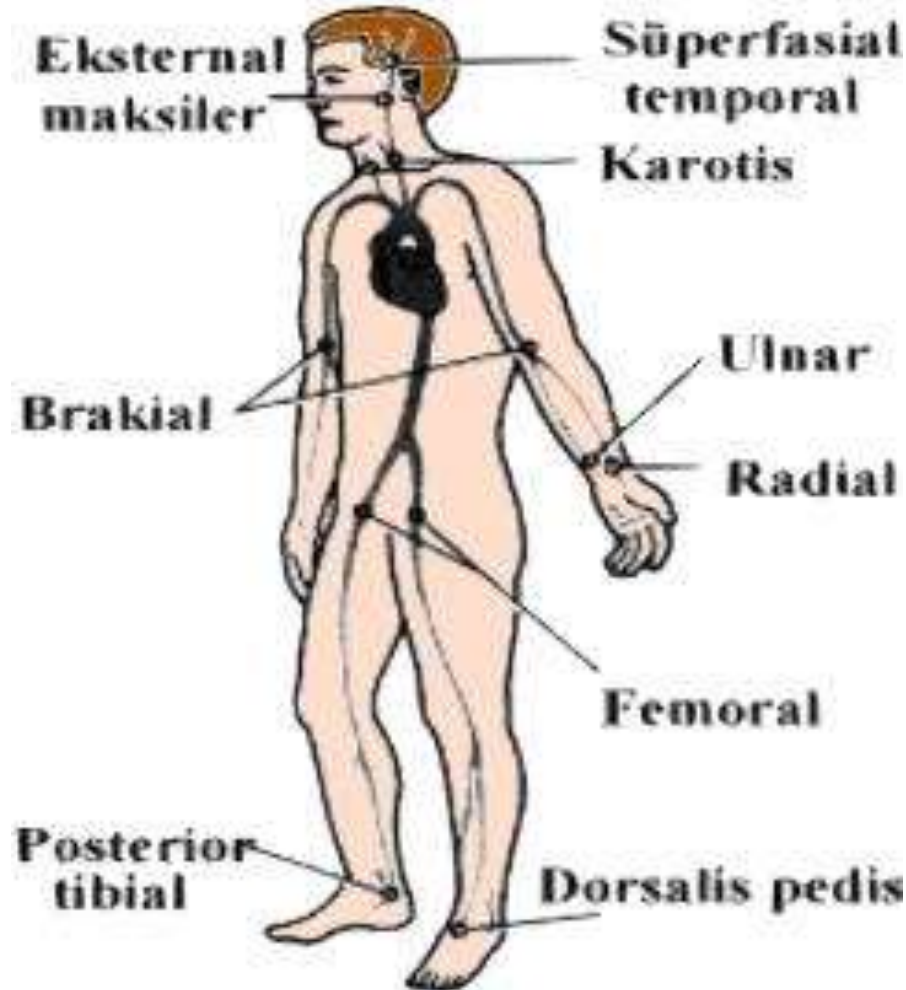
Solunumun değerlendirilmesi

- Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum yapıp yapmadığı 5 saniye süre ile değerlendirilir.
- Solunum hareketini ve canlılık belirtilerini (herhangi bir hareket var mı) gözlenir.
- Solunum sesini dinlenir.
- Yanağında hasta veya yaralının nefesini hissetmeye çalışılır.

- **Nabız (Dolaşım)**

- **Nabız, kalbin 1 dakika içinde kaç kere kasıldığını yani kalbin hızını yansıtır.**
- **Normalde yetişkinlerde 1 dakikadaki nabız sayısı 60-100 arasındadır. Ortalama 80 dir.**
- **Çocuklarda ve bebeklerde ise 100-120 dir.**

Nabız Alınan Arterler



Radyal Nabız Alma

- Normalde nabız, 15 saniye süresince sayılır, çıkan sayı 4 ile çarpılarak nabız bulunur.
- Kalp hastalarında 1dakika sayılır.





- **Vücut Isısı**
- İlk yardımda vücut ısısı daima koltuk altından ölçülmelidir.
- Normal değeri **36.5 c'** dir.

Koltuk Altı Isısının Alınması

**Termometrenin
koltuk altında
bekletilir.**



Olay Yerinde Yapılacaklar;

- 1. Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalı, kontağı kapatılmalı, el freni çekilmeli, araç LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanası kapatılmalıdır.**
- 2. Olay yeri yeterince görünebilir biçimde işaretlenmeli,**
- 3. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalı,**
- 4. Olay yerinde sigara içilmemeli,**

5. Gaz varlığında zehirlenmelere karşı önlem alınmalı,
6. Ortam havalandırılmalı,
7. Kıvılcım oluşturabilecek işlemler engellenmeli,
8. Hasta/yaralı **yerinden oynatılmamalı**,
9. Hızla yaşam bulguları yönünden **(ABC)** değerlendirilmeli,

10. Kırık ve kanama yönünden değerlendirilmeli ve **sıcak** tutulmalı,

11. Bilinç kapalı ise ağızdan bir şey verilmemeli,

12. Nazik ve hoşgörülü olunmalı,

13. Yarasını görmesine izin verilmemeli (**panik yapabilir**),

14. Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmeli, yardım gelene kadar **olay yerinde** kalınmalıdır.

İLK YARDIM GEREKTİREN DURUMLAR

- Solunum durması
- Kalp durması
- Kanamalar, şok
- Travma ve yaralanmalar (özellikle baş, göğüs, batin travma ve yaralanmaları),
- Yanıklar
- Kırık ve çıkıklar
- Komalar
- Zehirlenmeler,
- Böcek sokmaları

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ

- Hava yolunun açık tutulması
- Kanama kontrolü
- Ağrının giderilmesi
- Kırık tespiti
- Triage (ayırım)
- Ölüm tespiti

DİKKAT !!!...

- Uyarmada hastanın omzuna vurularak yüksek sesle iyi olup olmadığı sorulmalıdır. Böylelikle hastanın kendinde olup olmadığı anlaşılabilir.
- Eğer hasta bilinçliyse ve konuşuyorsa bu işlemin yapılmasına gerek yoktur.



DİKKAT !!!...

**Soluk alıp veren ve nabız vuruşları
hissedilen bir hastaya baygın olsa
bile kesinlikle kalp-akciğer
canlandırması yapılmaz!**

İLK YARDIMIN TEMEL İLKELERİ

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ :

- **A : AIRWAY (HAVAYOLU)**
- **B: BREATHING (SOLUNUM)**
- **C: CIRCULATION (KAN DOLAŞIMI)**

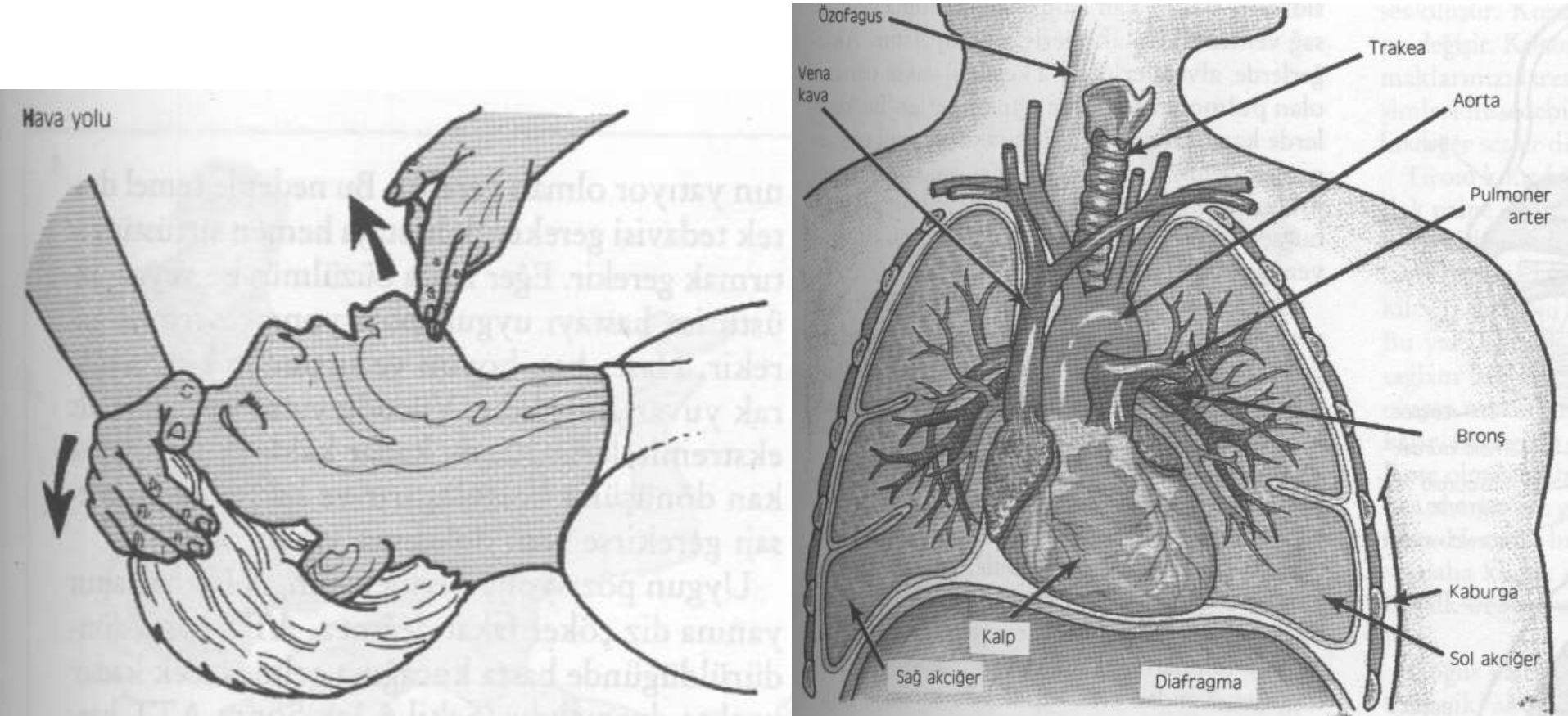
• ~~A B C~~

C A B

2010

A : AIRWAY

HAVAYOLUNUN AÇIK TUTULMASI



A. Havayolu Açıklığının Değerlendirilmesi:

- Bilinç kaybı belirlenmiş kişide; ağız içine **önce göz ile bakılmalı**, eğer yabancı cisim var ve çıkarılabileceği düşünülüyor ise **işaret parmağı yandan ağız içine sokularak** cisim çıkartılmalıdır.

- Daha sonra bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine koyulur, alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilip **BAŞ GERİ –ÇENE YUKARI** pozisyonu verilir.



1A- SÖZLÜ OLARAK YANIT VAR (+) (Bilinç Açık)

- Ani solunum arresti
- Bilinç kaybı
- Siyanoz

YABANCI CİSİM



Hava Yolu Tıkanıklığı Nedir?

- Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır.
- Tıkanma **kısmi tıkanma** ya da **tam tıkanma** şeklinde olabilir.

1. Kısmi Tıkanma

Kısmi tıkanma belirtileri:

- **-Öksürür,**
- **-Nefes alabilir,**
- **-Konuşabilir.**

Bu durumda hastaya dokunulmaz, **öksürmeye teşvik edilir.**

1. Kısmi Tıkanmada İlk Yardım

- **a.** Ayakta ise arkasında durulur.
- **b.** Kazazede aynı pozisyonda bırakılır.
- **c.** Öksürüğü azalır ve solunumu zayıflarsa derhal girişimde bulunulur.

2. Tam Tıkanma

Tam tıkanma belirtileri:

- -Nefes alamaz,
- -Acı çeker, ellerini boynuna götürür,
- -Konuşamaz,
- -Rengi morarmıştır.

2. Tam Tıkanmada İlk Yardım

- **a.** Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.
- **b.** Hastanın yanında veya arkasında durulur,
- **c.** Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır,
- **ç.** Diğer elin topuğu ile hızla **5 kez sırtına**
- (kürek kemikleri arasına) **süpürür tarzda** vurulur,
- **d.** Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.

2. Tam Tıkanmada İlk Yardım



2. Tam Tıkanmada İlk Yardım (devam)

- e. Tıkanıklık açılmadıysa **heimlich manevrası** yapılır.
- f. Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır,
- g. Bir elin başparmağı midenin üst kısmı, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.
- h. **Gazoz kapağı açar gibi** arkaya ve yukarı doğru bastır.

2. Tam Tıkanmada İlk Yardım



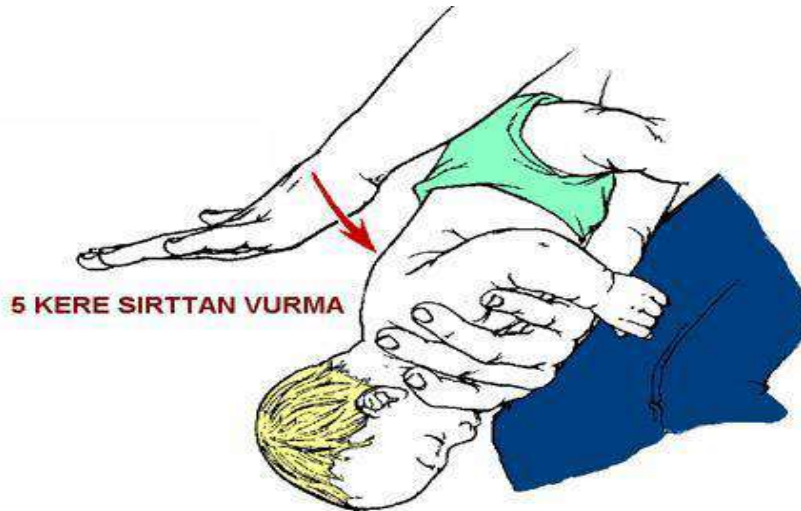
2. Tam Tıkanmada İlk Yardım (devam)

- **ı.** Bu hareketlerin her biri **5'er kez olacak şekilde** yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.
- **i.** Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.
- **j.** Tıbbi yardım istenir **(112)**.
- **k.** Temel yaşam desteğine başlanır.

Bebeklerde tam tıkanıklık olan hava yolunun açılması

- -Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla çenesi kavranarak boynundan tutulan bebek, **yüz üstü pozisyonda** ilk yardımcının **bir kolu üzerine yatırılır ve öne doğru eğilir.**
- -Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur.
- -**5 kez** el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına **kürek kemiklerinin arasına** hafifçe vurulur.

- Bebeğin durumu kötüleşirse,
- -Tıbbi yardım istenir (112),
- -Temel yaşam desteğine başlanır.





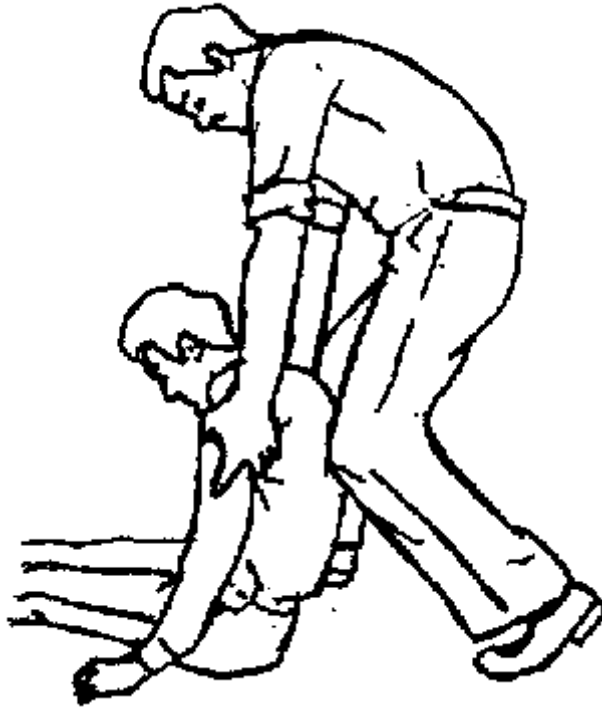
A : AIRWAY

YABANCI MADDELERİN ÇIKARTILMASI

ELLE



SIRTA VURMA YÖNTEMİ



A : AIRWAY

YABANCI MADDELERİN ÇIKARTILMASI

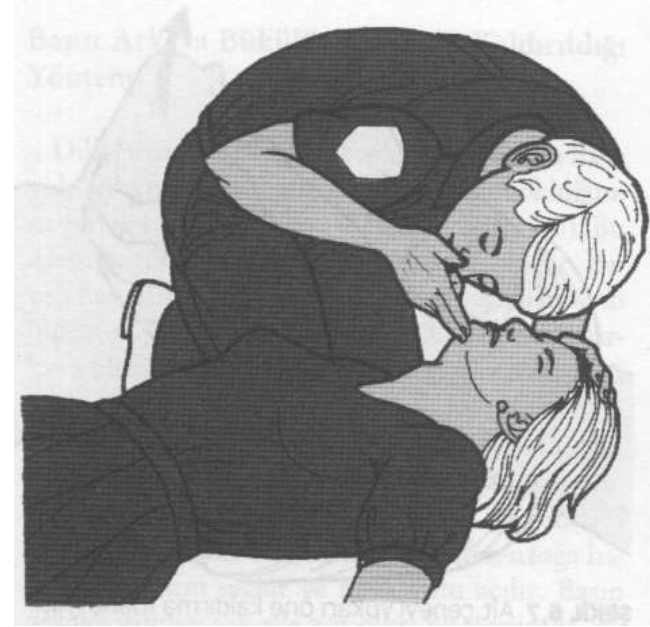
HEIMLICH MANEVRASI



B : BREATHING

SOLUNUMUN AÇIK TUTULMASI

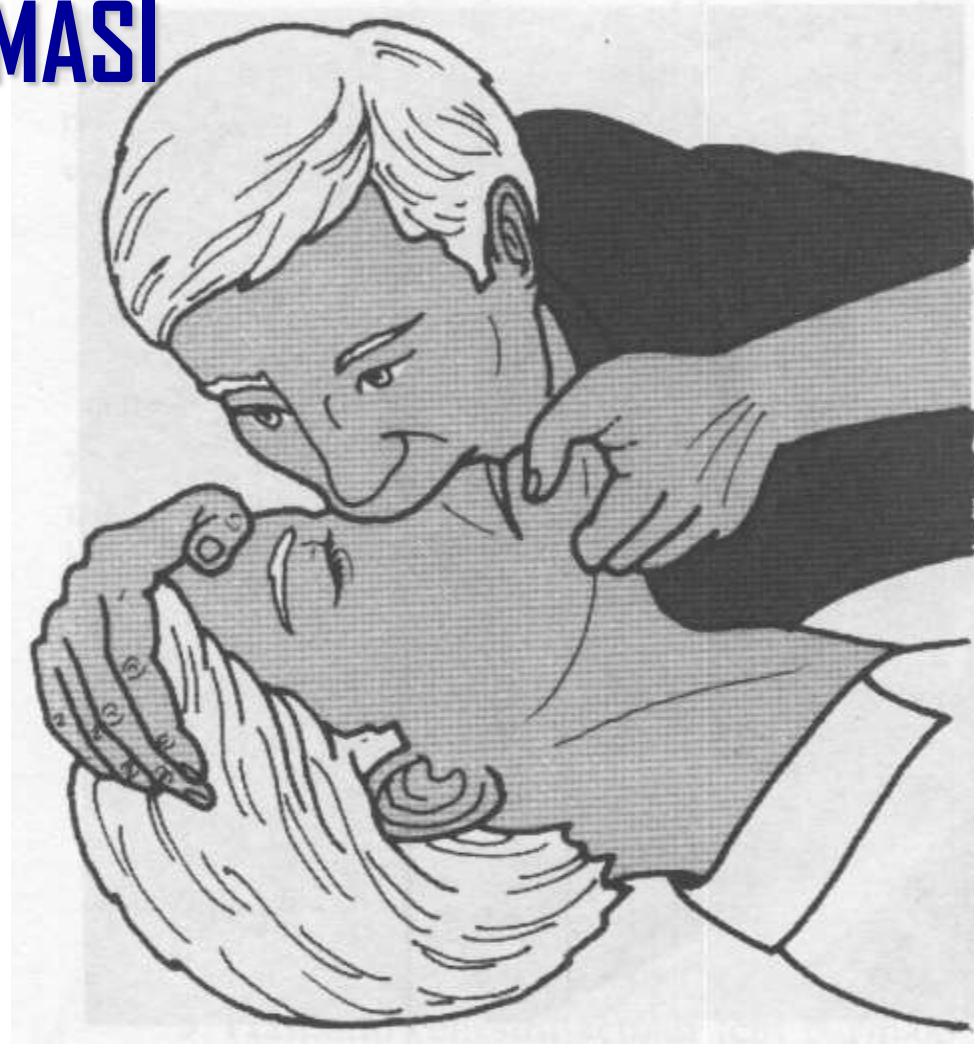
SUNİ TENEFFÜS



B : BREATHING

SOLUNUMUN AÇIK TUTULMASI

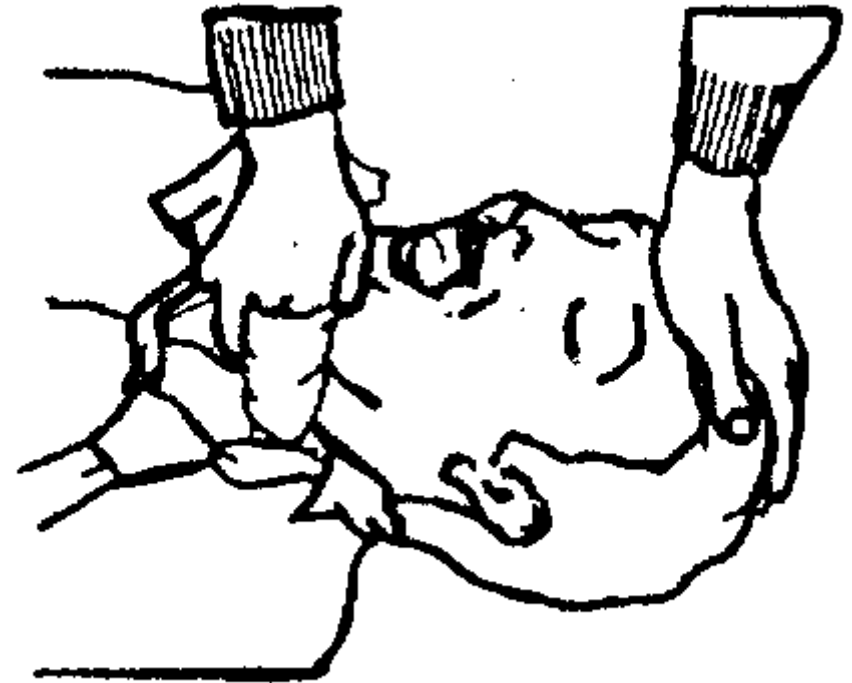
SUNİ TENEFFÜS



B : BREATHING

AŞAMA 1

SOLUNUM YOLLARININ AÇIK
TUTULMASI

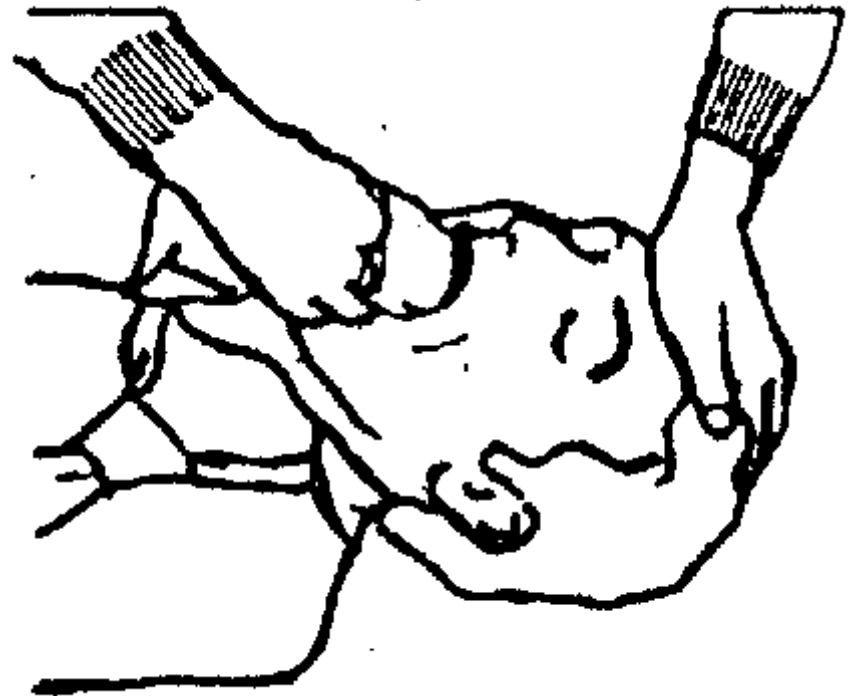


B : BREATHING

AŞAMA 2

AĞZIN

TEMİZLENMESİ



B : BREATHING

AŞAMA 3

BURUN TIKANMASI VE
ÜFLEMeye HAZIRLIK



B : BREATHING

AŞAMA 4

ÜFLEME



B : BREATHING

AŞAMA 5

EDİLGİN SOLUK VERME



B : BREATHING

AŞAMA 6

BİR DAHA ÜFLEME



C : CIRCULATION

KAN DOLAŞIMI SAĞLANMASI

Dışarıdan kanayan bir yara olup olmadığına bakılarak kanayan yer varsa basınçlı tampon uygulanmalı,

Hemen nabzın atıp atmadığına bakılmalıdır.

Nabız yoksa suni solunumla beraber kalp masajına başlanmalıdır.

Şok durumu varsa hastaya buna göre pozisyon verilmelidir.

KANAMA VE ÇEŞİTLERİ

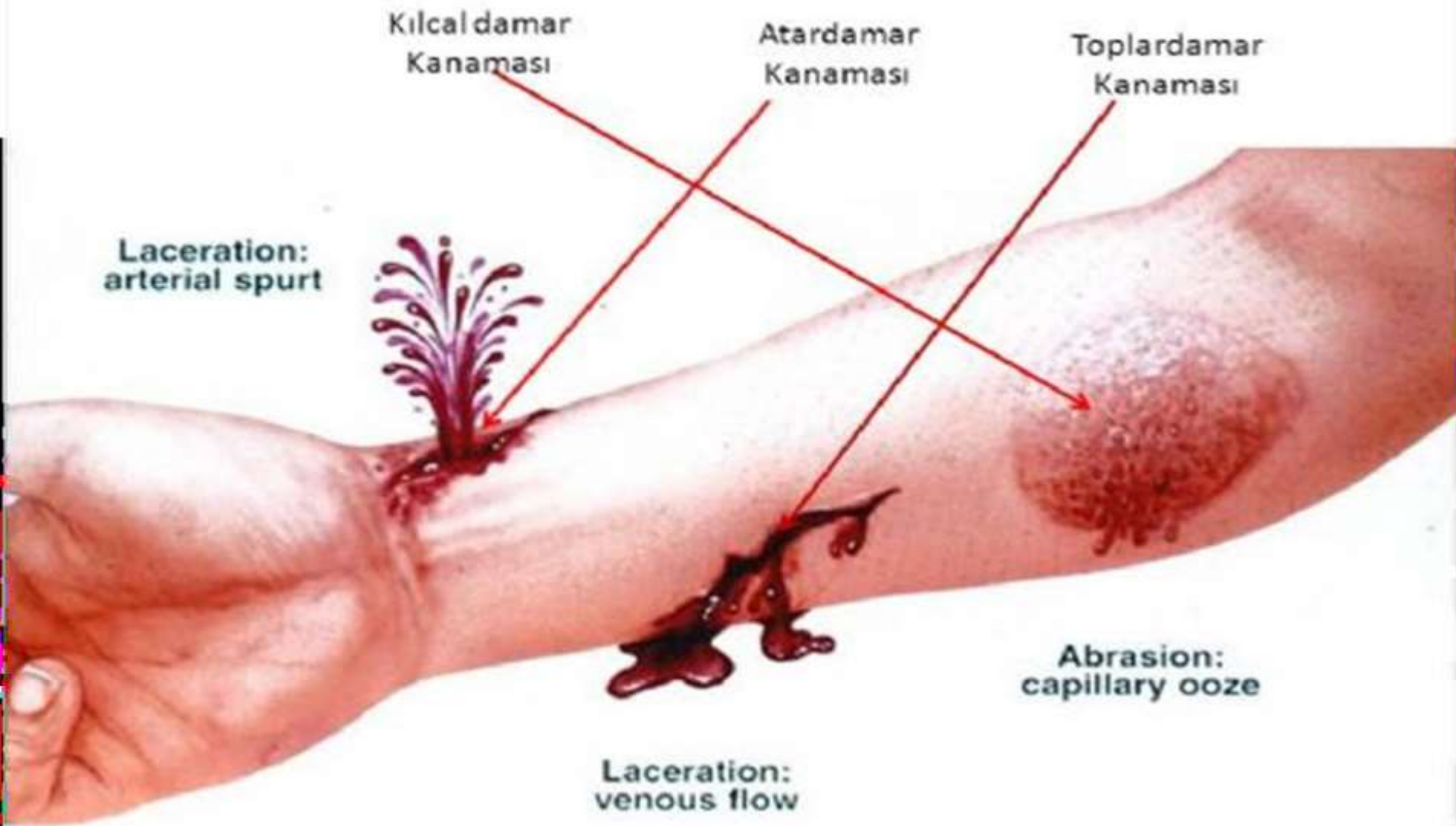
Kanama; Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına doğru akmasıdır.

Kanama çeşitleri

Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur.

İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.

Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır.



DIŞ KANAMALARDA İLK YARDIM

- Hasta veya yaralının durumu değerlendirilir,
- Tıbbi yardım istenir (112),
- Yara üzerine doğrudan baskı uygulanır,
- Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır,
- Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır,
- Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır,
- Kanayan bölge yukarı kaldırılır,

- **Hasta ve yaralının ayakları 30 cm kaldırılarak şok pozisyonu verilir,**
- **Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta veya yaralının üstü örtülür,**
- **Asla yiyecek ve içecek verilmez,**
- **Hareket ettirilmez.**

İÇ KANAMALARDA İLK YARDIM

- Hasta veya yaralının bilinci değerlendirilir,
- Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır,
- Tıbbi yardım istenir (112),
- Asla yiyecek ve içecek verilmez,
- Hareket ettirilmez.

Burun Kanaması

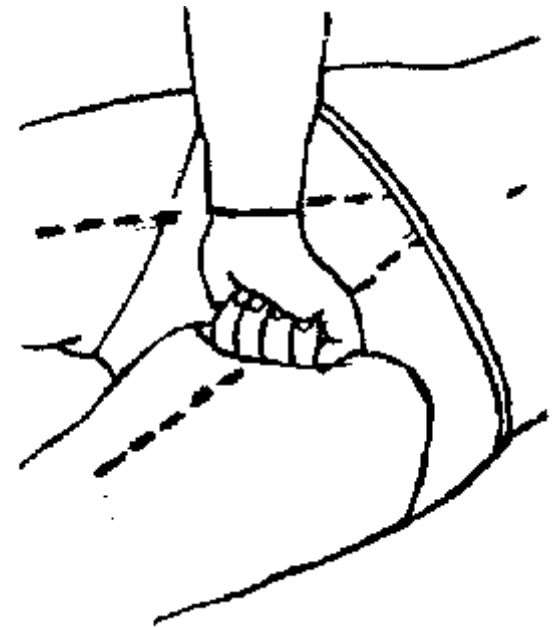
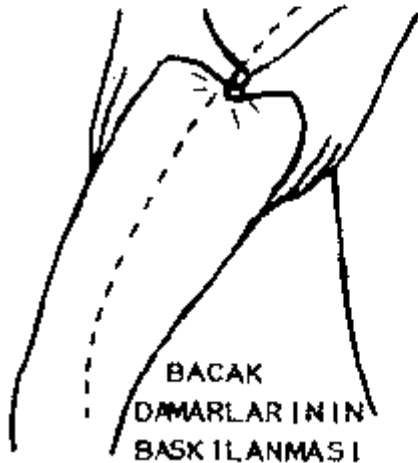
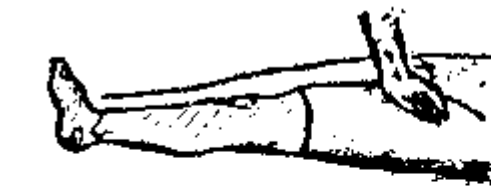
- Hasta veya yaralı sakinleştirir endişeleri giderilir
- Oturtulur.
- Baş hafifçe öne eğilir.
- Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır.

Burun Kanaması



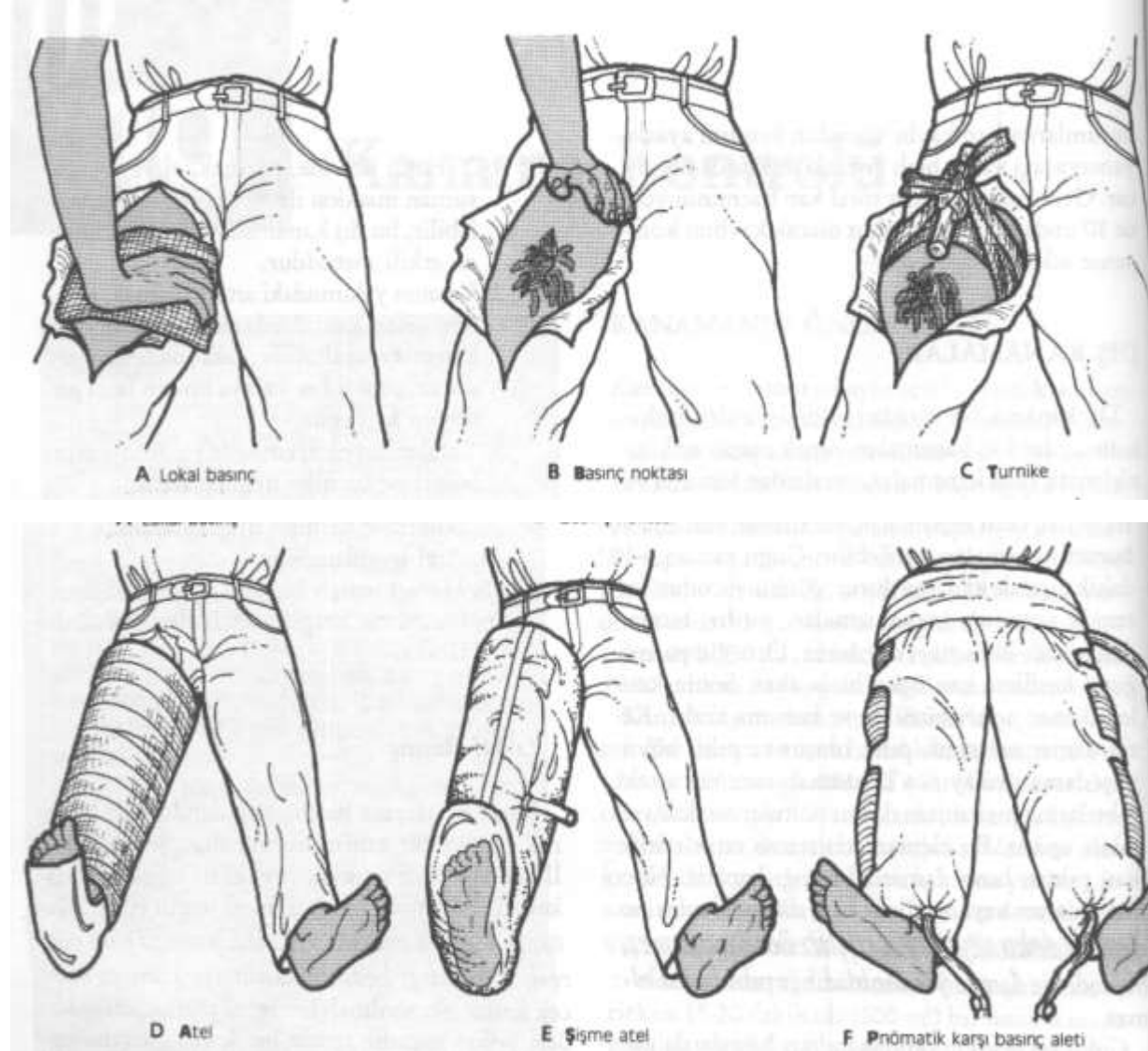
İLK YARDIMIN TEMEL KRİTERLERİ

KANAMA KONTROLÜ



İLK YARDIMIN TEMEL KRİTERLERİ

KANAMA KONTROLÜ



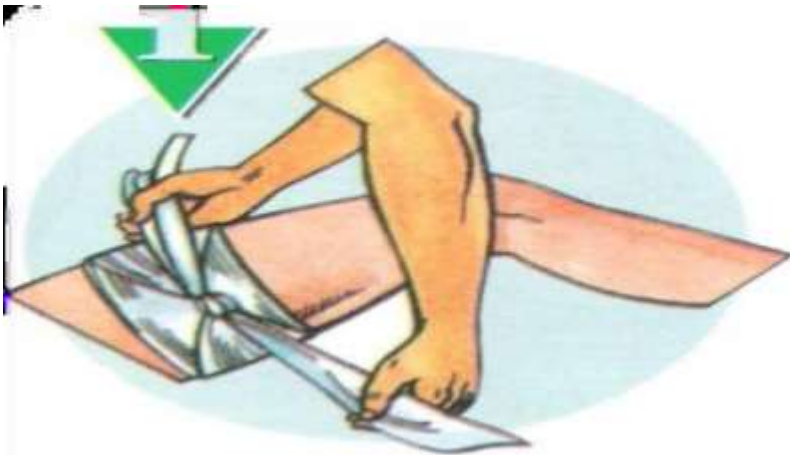
Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?

- Bugün için turnike başlıca 3 durumda uygulanmaktadır. Bunlar:
- Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için)
- Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa,(engebeli uzun bir yola gidilecekse)
- Uzun kopması varsa baskı noktasından yapılan baskı etkisiz ise turnike uygulanabilir,bunların dışında kesinlikle uygulanmaz.

- **Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?**
- **Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8-10 cm olmalıdır.**
- **Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır.**

- **Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir.**
- **Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.**

Boğucu Sargı (Turnike) Uygulaması



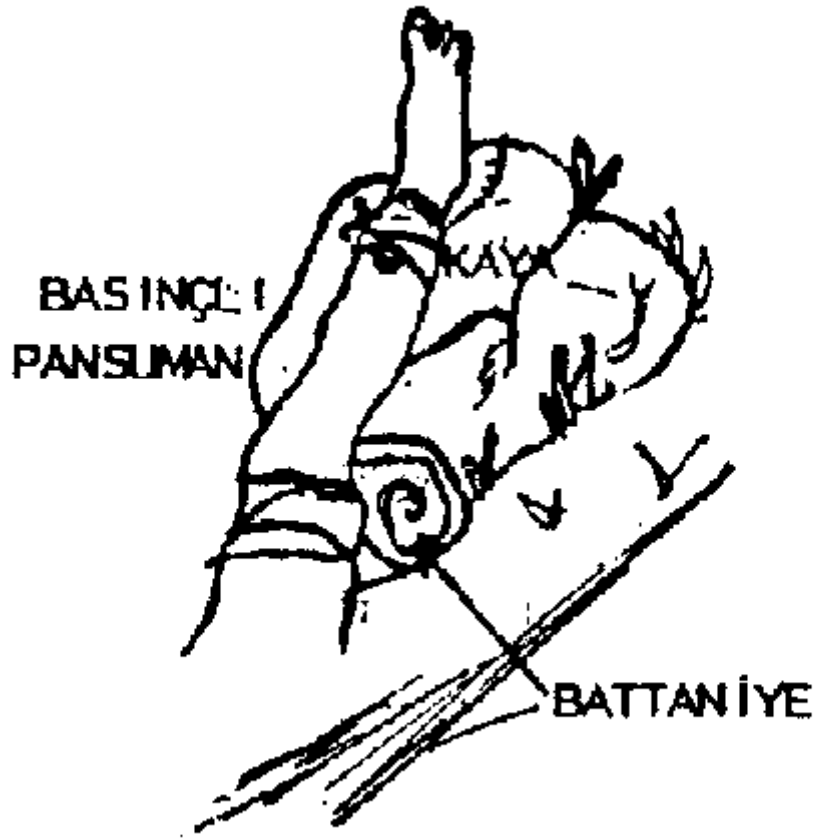
- **Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.**
- **Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.**
- **Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmelidir.**

İLK YARDIMIN TEMEL KRİTERLERİ

KANAMA KONTROLÜ

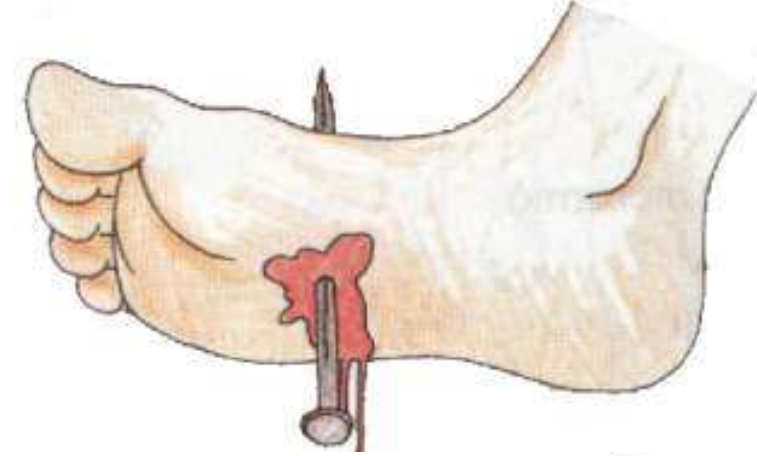
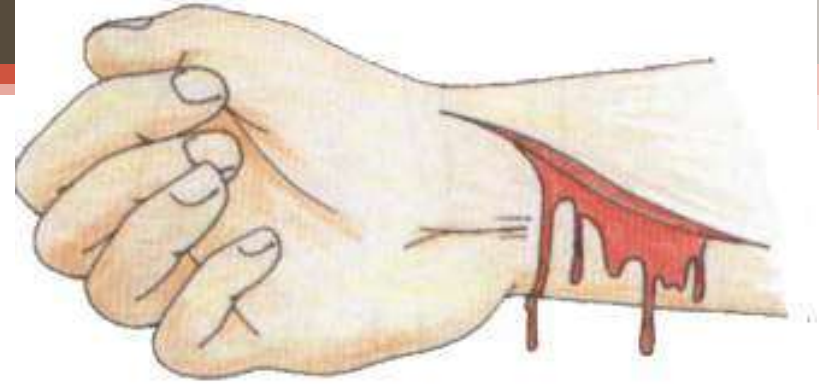


KANAYAN YERİN YÜKSEKTE TUTULMASI



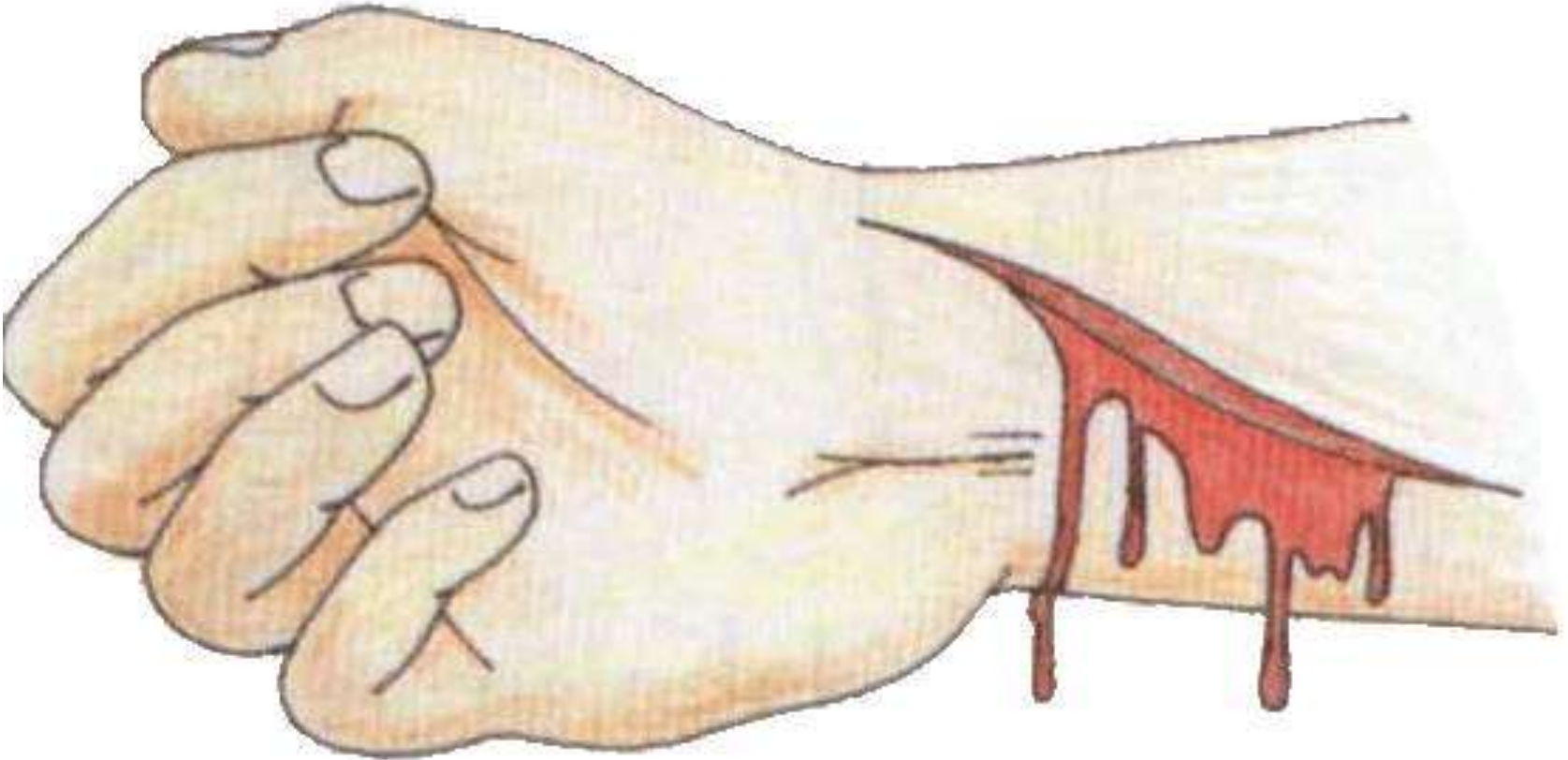
KESİK

**Bıçak / Jilet / Makas / Satır
Balta / Cam kırığı / Çivi
Teneke parçası gibi
kesici ve delici aletlerin
vücudu örten deri üzerinde
meydana getirdikleri
hasarlardır**



Kesiğin az veya çok olmasına bakılmaksızın en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek **TETANOZ AŞISI yaptırılmalıdır**

Kesiklerde en önemli tehlike **KAN KAYIBIDIR**



KESİKLERDE YAPILACAK İLK MÜDAHALE

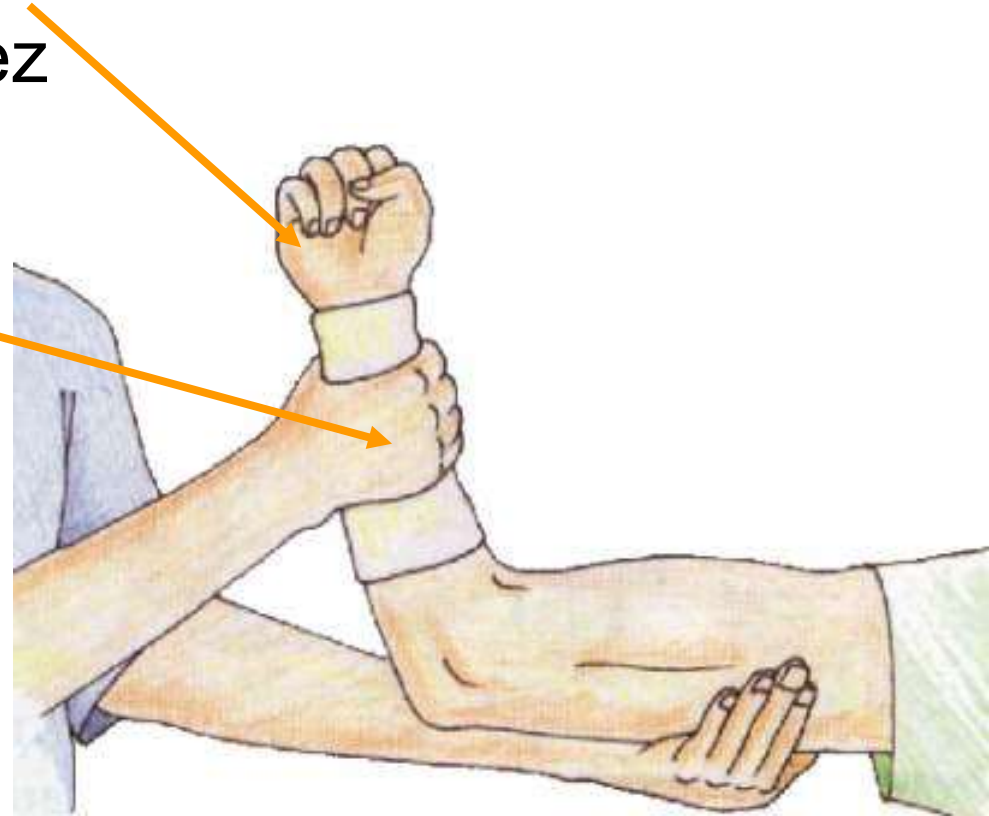


- Kesici / delici aleti KESİNLİKLE ÇIKARMAYIN
- Kesiği sabunlu suyla ve temiz bir bezle yıkayın
- Kesik üzerinde dışardan görülebilen yabancı cisim varsa alın
- Kesiğin üzerine tentürdiyot ve oksijenli su sürmeyin

DİKKAT

**TÜM AÇIK YARALANMALARDA
BATAN CİSMİ ÇIKARTMA**

- Kesikte sızıntı şeklinde kanama varsa kanayan kısmı kalp hizasından yukarıya gelecek şekilde kaldırın
- Üzerine temiz bir bez koyarak bastırın
- Kanama durursa fazla sıkmadan bağlayın



➤ **KESİK YARALANMALARINDA YARALI
EN GEÇ 6 SAAT İÇİNDE BİR SAĞLIK
KURULUŞUNA GÖTÜRÜLMELİDİR**

KESİKLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- **Kesik yaraların üzerine toz / merhem sürmeyin**
- **Yaranın üzerini kirli bezle sarmayın**
- **Yara üzerine basınç yaparak kanamayı durdurmaya çalışın**

Dış Kanama Kontrolü-1



Dış Kanama Kontrolü-3



Dış Kanama Kontrolü-2



Dış Kanama Kontrolü-4

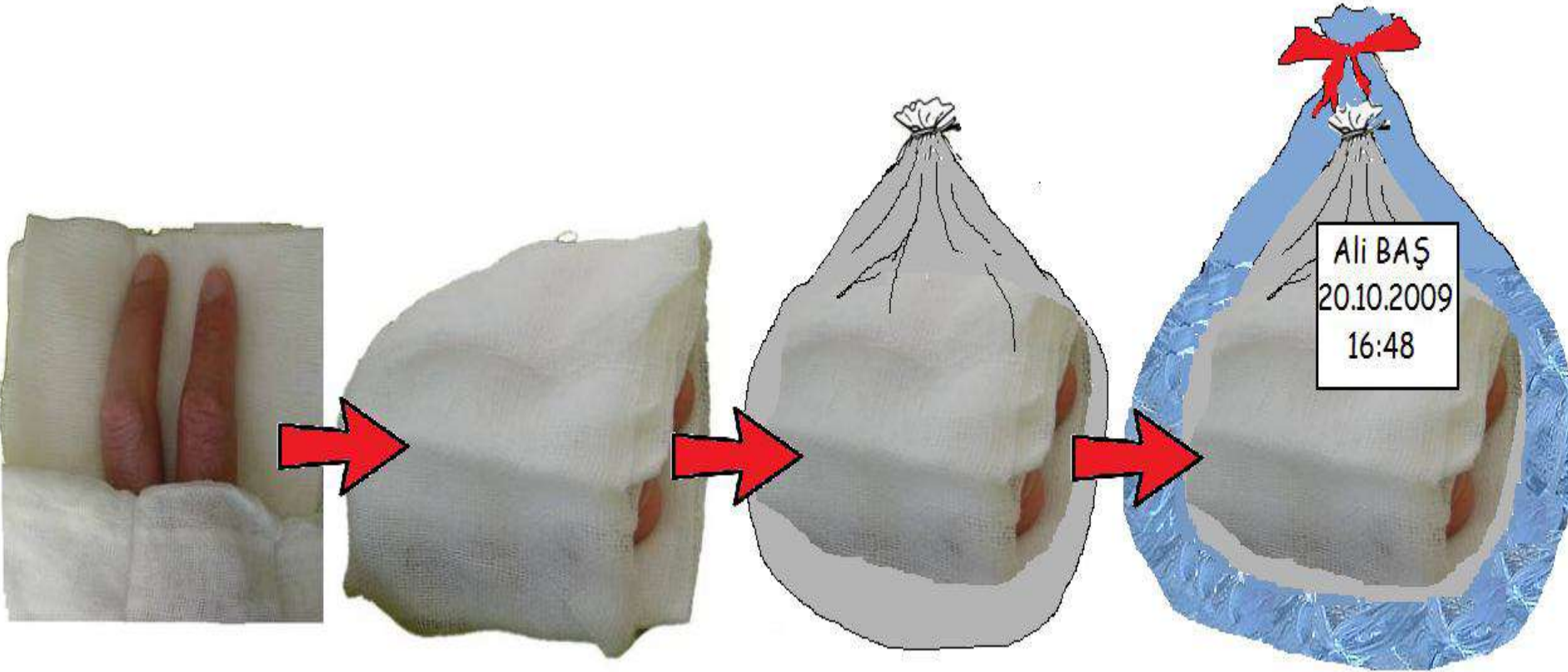


- Delici göğüs yaralanmalarında yaralının bilinci yerindeyse yarı oturur şekilde oturtulur ve sırtı desteklenir.
- Delici karın yaralanmalarında hasta sırt üstü yatırılır.

ORGAN KOPMASI



- Kopan organ temiz ve kuru bir gazlı beze sarılır plastik bir torbaya konduktan sonra ağzını kapatılır
- Bu torba, içinde buz bulunan ikinci bir torbanın içine konulmalıdır.
 - Böylece uzuv, buza doğrudan temas etmeden soğuk ortamda taşınmış olur.



Kopan organın taşınması

YARALININ POZİSYONU VE TAŞINMASI



YARALININ POZİSYONU VE TAŞINMASI

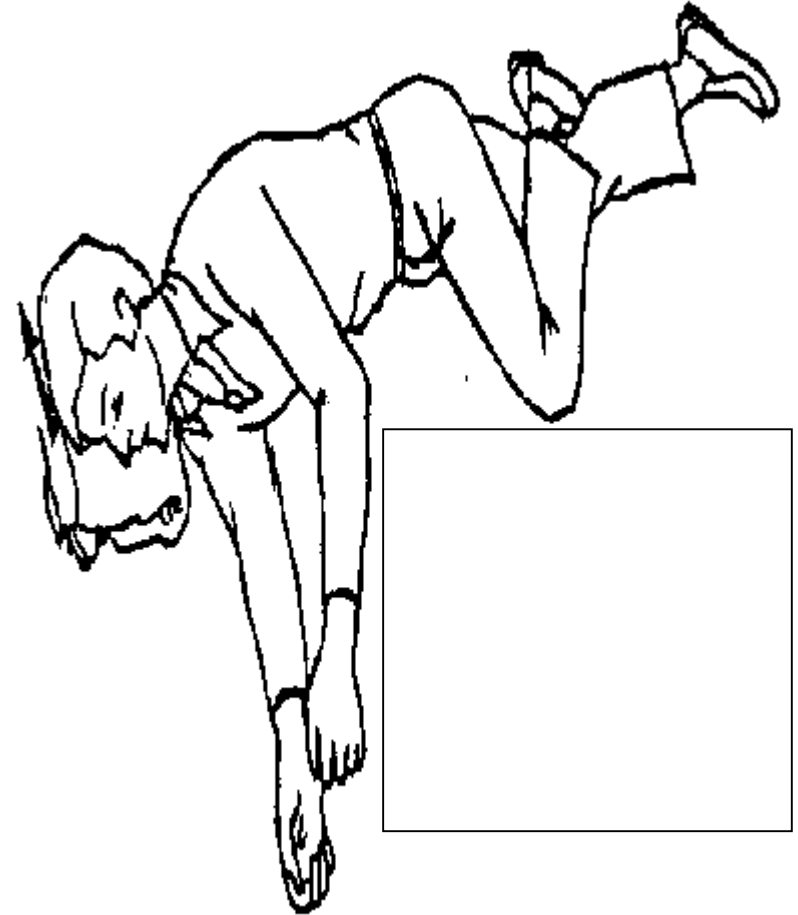
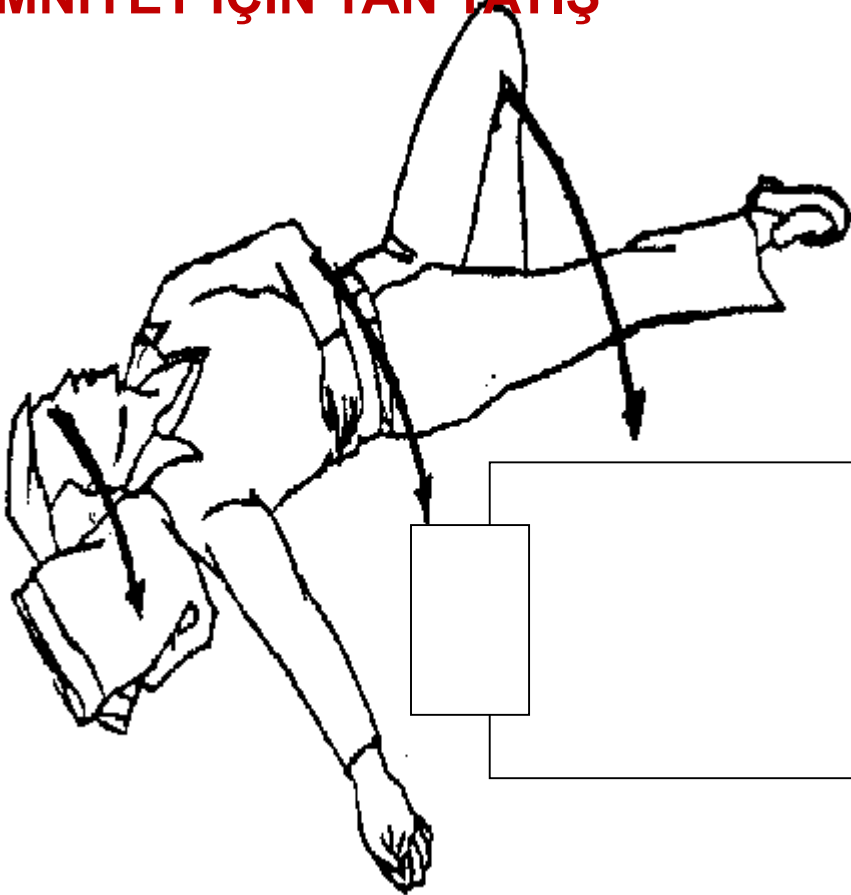


YARALININ POZİSYONU VE TAŞINMASI



YARALININ POZİSYONU VE TAŞINMASI

EMNİYET İÇİN YAN YATIŞ



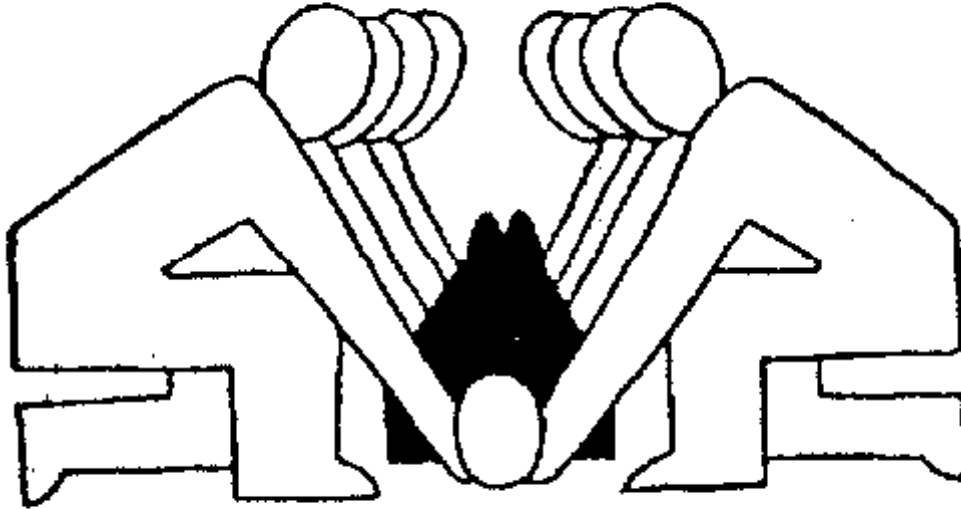
YARALININ POZİSYONU VE TAŞINMASI

EMNİYET İÇİN YAN YATIŞ



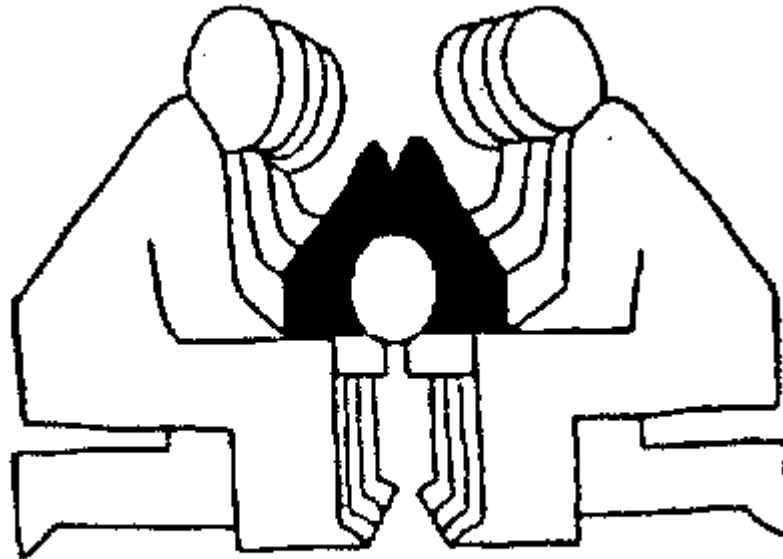
YARALIYI TAŞIMA

ELLER ÜZERİNE ALMA



YARALIYI TAŞIMA

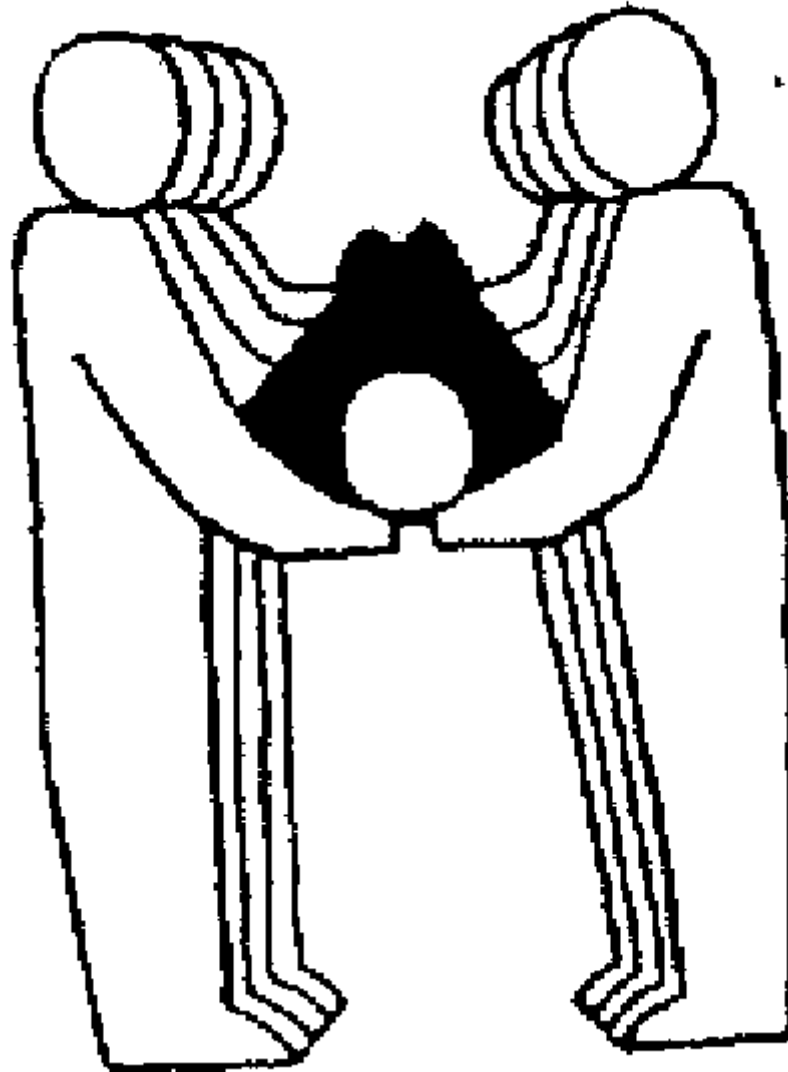
KALDIRMA



KALDIRMA

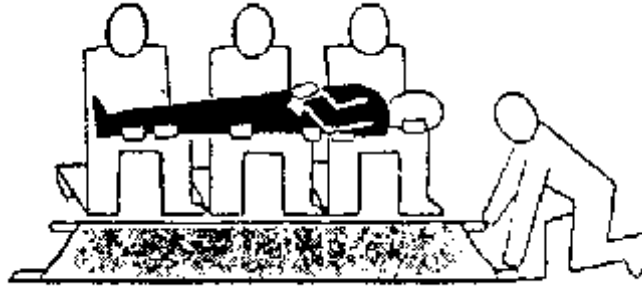
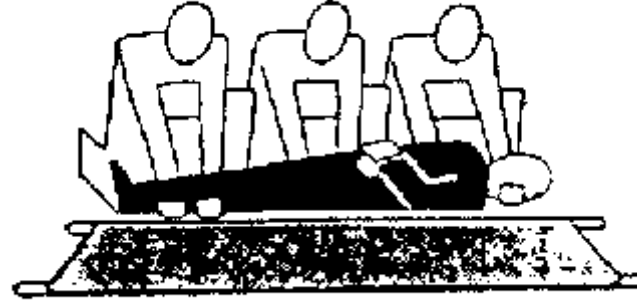
YARALIYI TAŞIMA

KALDIRMA



YARALIYI TAŞIMA

SEDYEYE ALMA



ŞOK DURUMU

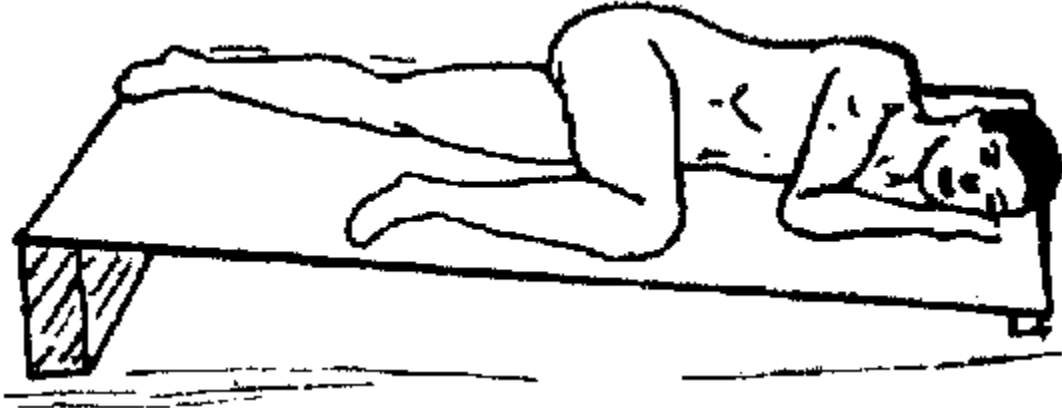
- BİR İNSAN, $\frac{1}{2}$ Lt ANİ KAN KAYBINDAN ETKİLENMEZ.



- 1 Lt KAN KAYBINDA AYAĞA KALKINCA BAŞI DÖNER



- 1,5 Lt KAN KAYBINDA ŞOKA GİRER



ŞOK DURUMU

DİKKAT !!

**ŞOK ANINDA İLK YAPILACAK ŞEY
BEYİNE KAN ULAŞIMININ
SAĞLANMASIDIR.**

YANIK

- Su buharı / Su / Sıcak sıvılar
- Ateş
- Sıcak cisim
- Elektrik
- Aşırı güneş ışını
- Kimyasal maddeler (asit ve baz) 'in

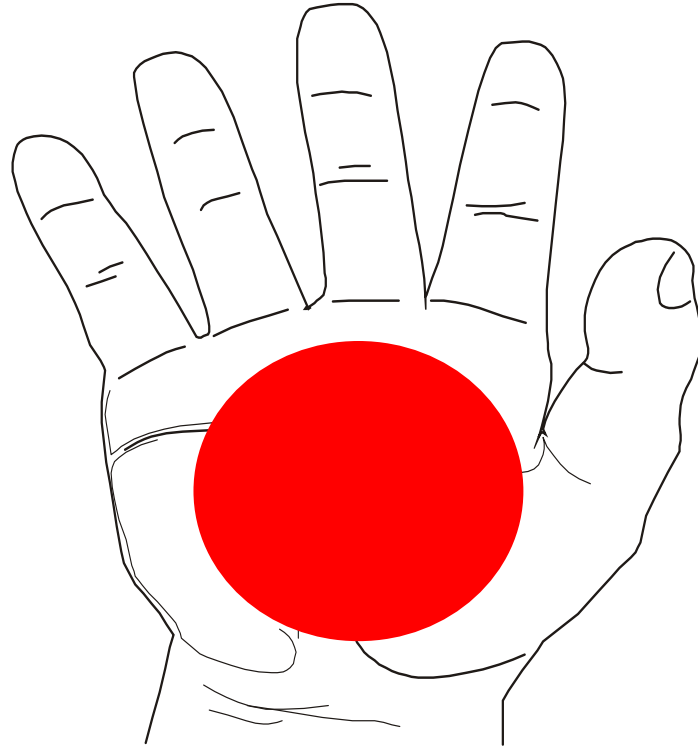
İnsan vücuduna temas etmesi sonucunda vücutta meydana gelen doku harabiyetidir.

YANIK

Her yıl iki milyondan fazla tedavi gerektiren yanık yaralanmaları olmaktadır.

En az yılda 6000 kişi yanık ile alakalı yaralanmalardan dolayı ölmektedir.

**Avuç içinden büyük her yanık vakasını
hastaneye sevk et !**



Yanık sınıflandırmaları :

Birinci Derece/Sathi

Derinin üst katı yanmıştır. Deri kızarır ve kabarcıklar oluşur.



İkinci Derece/Kısmi

Derinin üst katları yanmıştır.
Deri kızarır ve kabarcıklar oluşur.
Genellikle bu yanık ağrılıdır.



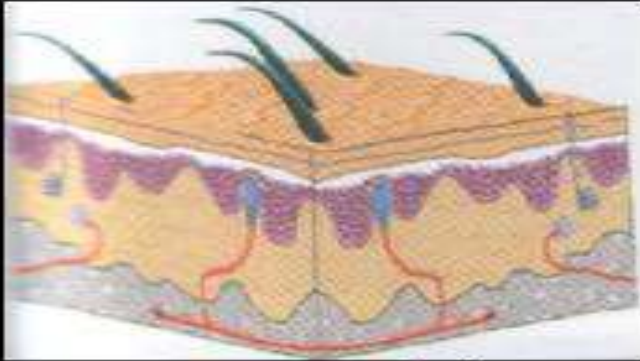


Üçüncü Derece/Tam

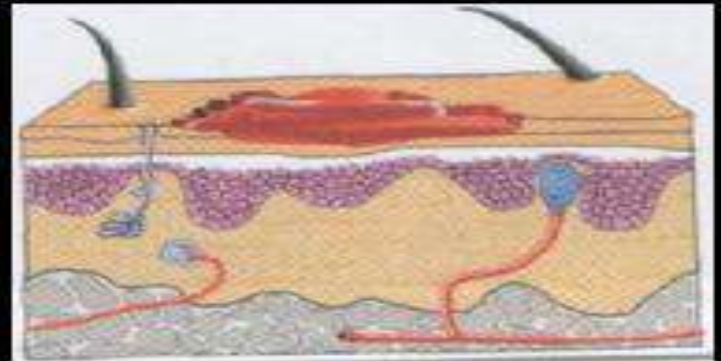
Alt tabakalarla (yağ,kas,kemik, ve sinirler) birlikte tüm deri tabakası yanmıştır.

Bu tür yanıklar oldukça ağrılı olabileceği gibi, sinirlerin ölmesinden dolayı ağrısız da olabilir.

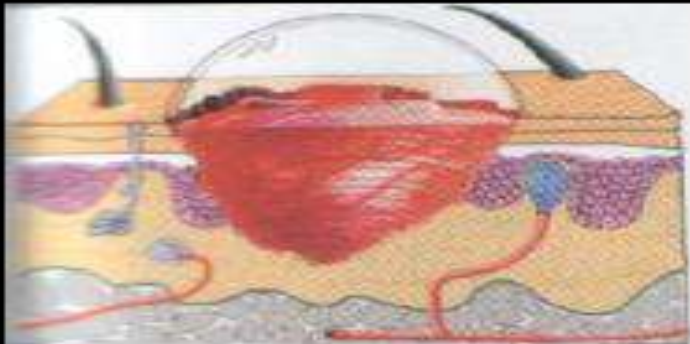




yanmamış deri



I. Dereceden yanık



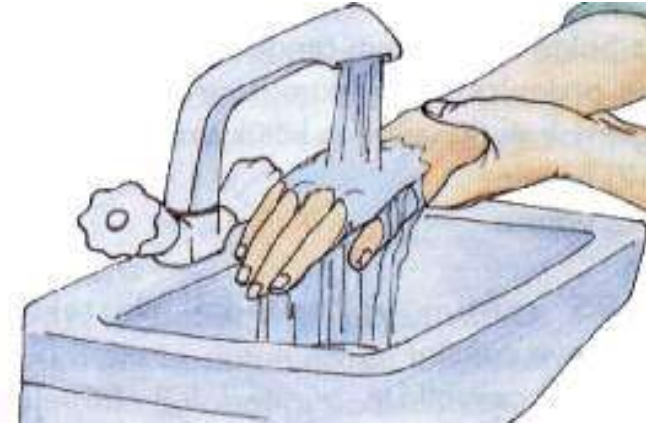
II. Dereceden yanık



III. Dereceden yanık

YANIKDA YAPILACAK İLK MÜDAHALE

- Yanık bölgeyi **soğuk su** altına tutun.
- Deri tamamen sıyrılmışsa soğuk suya tutun ve üzerine buz koyun.
- Yaniğın üzerini temiz bir bez
- Yanan kişiyi sakinleştirin
- Yanan kişinin elbiselerini keserek çıkarın
- Hemen bir sağlık kuruluşuna götürün



YANIKTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Yanık kabarcıklarını patlatmayın
- Yanan kişinin elbiselerini çekerek çıkarmayın
- Ağır yanıklarda ağızdan yiyecek / içecek vermeyin
- Yanık bölge üzerine hiçbir şey sürmeyin

YANIK YÜZEYİNE DİŞ MACUNU, SALÇA, YOĞURT GİBİ MADDELER KESİNLİKLE SÜRÜLMEMELİDİR.

- Yanık üzerine kirli bez koymayın

- Parmak ve eklemlerde iki dokunun birbirini ile temasını önleyin.

YANIKTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YANLIŞ



DOĞRU



SICAK ÇARPMASINDA İLK YARDIM

- Yüksek derecede ısı ve nem sonucu vücut ısının ayarlanamaması sonucu ortaya bazı bozukluklar çıkar.

→ Kas krampları

→ Güçsüzlük, yorgunluk

→ Davranış bozukluğu

→ Solgun ve sıcak deri

→ Bol terleme

→ Mide krampları, bulantı kusma

→ Bilinç kaybı, hayal görme

→ Hızlı nabız



Güneş çarpmasında yapılacak ilk müdahale



- Hasta/yaralı sıcak ya da güneşli ortamdan hemen uzaklaştırılmalı, serin, gölgeli ve havadar bir yere alınmalıdır.
- Sırt üstü yatırılmalı, giysileri çıkarılmalı, hatta tamamen soyulmalıdır.
- Şok belirtisi varsa, ayaklarının altı desteklenerek yukarı kaldırılmalıdır.

- Kusma varsa, yan yatırılmalıdır.
- Soğuk suya batırılmış bir bezle, başından başlayarak kompres yapılmalıdır.
- Hastanın bilinci açıksa ve mide bulantısı yoksa, su ve tuz kaybını gidermek için ağızdan tuzlu su (1 litre suya + 1 cay kaşığı tuz+ 1 cay kaşığı karbonat karıştırılarak hazırlanan) veya maden suyu içirilmelidir.

- Hasta/yaralıya, vücut sıcaklığını gereğinden fazla düşürmeden soğuk suyla banyo yaptırılmalıdır.

**Bilinç açık değilse kesinlikle
ağızdan hiç bir şey verilmez**

DONMALARDA İLK YARDIM

Aşırı soğuk nedeniyle ile soğuya maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi nedeniyle dokularda hasar oluşur.



- *Deride Solukluk, sogukluk hissi
- *Uyuşukluk ve halsizlik
- *Daha sonra kızarıklık ve iğnelenme hissi

- *Deride Solukluk, sogukluk hissi
- *Uyuşukluk ve halsizlik
- *Daha sonra kızarıklık ve iğnelenme hissi

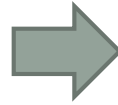
BİRİNCİ DERECE

- *Deride solukluk, soğukluk hissi
- *Uyuşukluk ve halsizlik
- *Daha sonra kızarıklık ve iğnelenme hissi



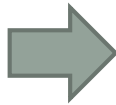
İKİNCİ DERECE

- *Zarar gören bölgede gerginlik hissi
- *Ödem, şişkinlik, ağrı ve içi su dolu kabarcıklar
- *Su toplanması iyileşirken siyah kabuklara dönüşür.



ÜÇÜNCÜ DERECE

- *Donukların geriye dönülmez biçimde hasara uğramasıdır.
- *Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur.



Donuklarda ilk yardım

- Hasta / yaralı ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir.
- Sakinleştirilir.
- Kesin istirahate alınır ve hareket ettirilmez
- Kuru giysiler giydirilir.
- Sıcak içecekler verilir.



- Su toplanmış bölgeler patlatılmaz, bu bölgelerin üzeri temiz bir bez ile örtülür.
- Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır.
- El ve ayak doğal pozisyonda tutulur (büzülmüş ise açılmaya çalışılmaz)
- Dolaşımın rahat sağlanması için el ve ayaklar yukarı kaldırılır.

ZEHIRLENME



SİNDİRİM YOLU İLE ZEHİRLENME VE İLK YARDIM

Bozuk besinler, zehirli mantarlar, bilinçsiz ilaç kullanımı vb. ağızdan alınması ile meydana gelir.

Belirtiler

Bulantı

Kusma

Karın ağrısı ishal

Bilinç kaybı

Solunum ve kalp durması.

SİNDİRİM YOLU İLE ZEHİRLENME VE İLK YARDIM

Bilinç kontrolü yapılır,

Zehirli madde ağza temas etmişse su ile çalkalanır, ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır,

Yaşam bulguları değerlendirilir,

Kusturulmaya çalışılmaz, Acil yardım istenir. (112)

KİŞİYİ KUSTURMAYA ÇALIŞMAYINIZ!

DERİ / SOLUNUM YOLU ZEHİRLENMELERİNDE İLK MÜDAHALE

Zehirli maddenin solunum yolu ile alınmasıyla oluşur.

Belirtiler

Nefes darlığı

Morarma

Bilinç kaybı

Solunum ve kalp durması

İlk Yardım

- Hasta temiz havaya çıkarılır yada cam ve kapı açılır.
- Yarı oturur pozisyon verilir.
- Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir.
- Acil yardım istenir. (112)

CİLT YOLU İLE ZEHİRLENME VE İLK YARDIM

Böcek sokmaları, hayvan ısırıkları, zirai ilaçlar gibi zehirli maddelerin deriden emilmesi ile oluşur.

Belirtiler

Kızarıklık

Kaşıntı

Bilinç kaybı

Solunum ve kalp durması

- **Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım**
- Zehirli madde ile ellerin teması önlenir.
- Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır,
- Deri 15-20 dakika bol suyla yıkanır,
- Acil yardım istenir (**112**)

ZEHIRLENMELERDE GENEL İLK YARDIM KURALLARI

- Zehirlenmeye neden olan madde ortamdan uzaklaştırılır,
- Hastanın bilinç durumunu kontrol edilir,
- Yaşamsal fonksiyonların devamı sağlanır,
- Acil yardım istenir (112)

- **114'Ü ARAYARAK ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNDEN YARDIM İSLEYİN!**

- Göze temas etmişse **15 dk suya** tutulur.

Hayvan Isırmalarında İlk Yardım

Kedi- Köpek Isırmalarında İlk Yardım



- Hastanın yaşamsal bulguları (nabız, solunum, ateş) değerlendirilir.
- Hafif yaralanmalarda yaralı olan bölge 5 dakika boyunca sabun ve soğuk su ile yıkanır ve temizlenir.



- Yaranın üzerine temiz bir bez kapatılır.
- Eğer yaralanma ciddi ise ve kan geliyorsa hemen yaraya temiz bir bez yardımı ile basınç uygulamak sureti ile kanın durdurulması sağlanır.



Arı sokmalarında ilk yardım



BELİRTİLER

- Belirtiler kısa sürer.
- Acı, şişme, kızarıklık gibi lokal belirtiler olur.
- Arı birkaç yerden soktuysa, nefes borusuna yakın bir yerden soktuysa ya da kişi alerjik bünyeli ise tehlikeli olabilir.

- Yaralı bölge yıkanır.
- Derinin üzerinden görülüyorsa arının iğnesi çıkarılır.
- Soğuk uygulama yapılır.
- Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa hastanın buz emmesi sağlanır.
- Ağız içi sokmalarında ve alerji hikayesi olanlarda tıbbi yardım istenir (Ambulans Tel: 112).



Akrep Sokmalarında İlk Yardım



BELİRTİLERİ

- Ağrı
- Ödem
- İltihaplanma, kızarma, morarma
- Adale krampları, titreme ve karıncalanma
- Huzursuzluk, havale

- Sokmanın olduđu bölge hareket ettirilmez.
- Yatar pozisyonda tutulur.
- Yaraya soğuk uygulama yapılır.
- Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır.
- Yara üzerine hiçbir girişim (kesilmez, emilmez) yapılmaz.



Yılan sokmalarında ilk yardım



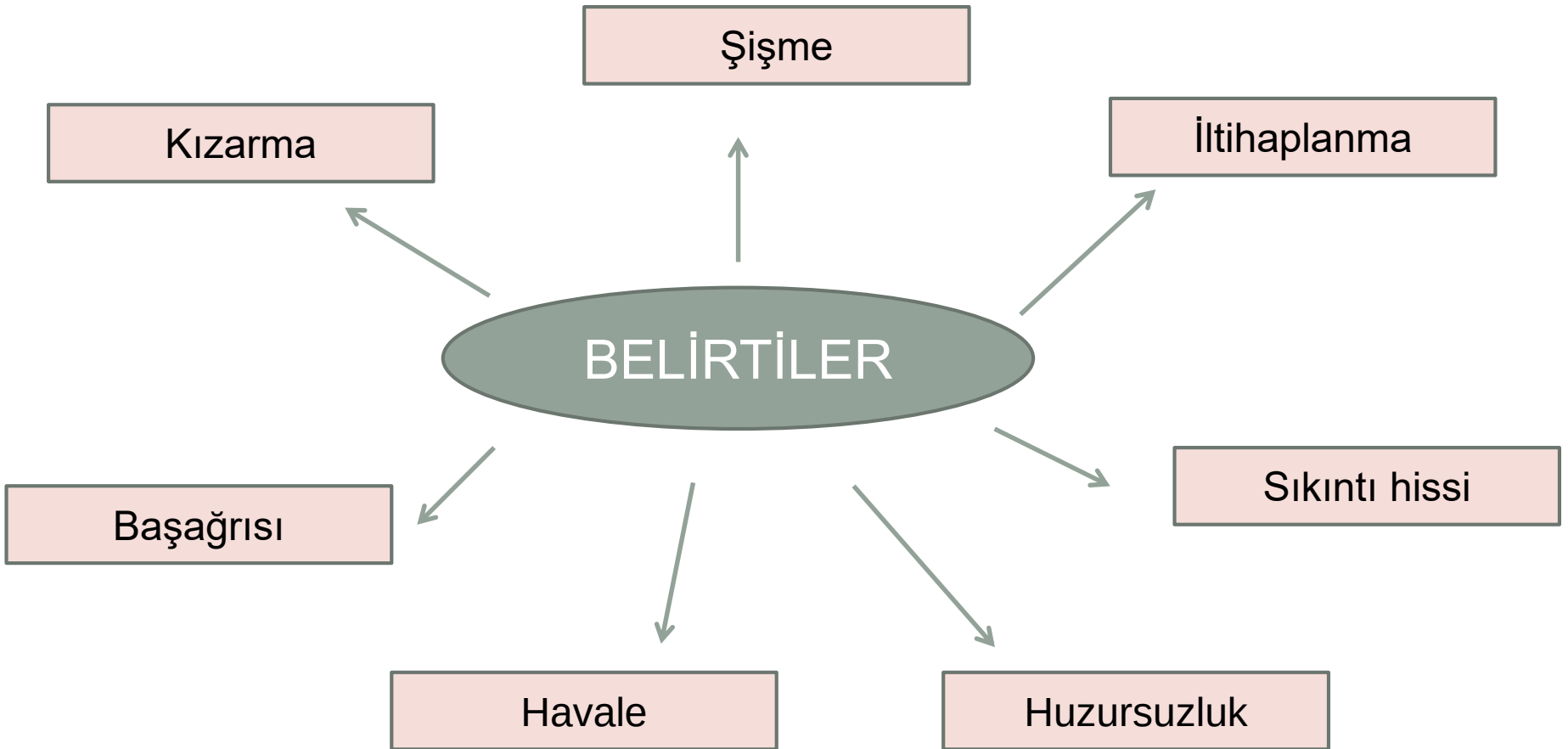
- Hasta sakinleştirilir, dinlenmesi sağlanır,
- Yara su ile yıkanır,
- Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar (yüzük, bilezik vb.) çıkarılır,
- Yara baş ve boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır,
- Yara kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde üstünden bandaj uygulanır,
- Turnike uygulanmaz,



- Soğuk uygulama yapılır.
- Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz (yara emilmez).
- Yaşamsal bulgular (nabız, solunum, ateş) izlenir.
- Tıbbi yardım istenir (Ambulans Tel: 112).



Deniz canlıları sokmasında ilk yardım



- Yaralı bölge hareket ettirilmez.
- Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılır.
- Etkilenen bölge ovulmamalıdır.
- Sıcak uygulama yapılmalıdır.



Göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım

- **Toz gibi küçük bir madde ise;**
- Göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır.
- Gerekirse üst göz kapağı açık tutulur.
- Nemli temiz bir bezle toz çıkarılmaya çalışılır.
- Hastaya gözünü kırpmasını söylenir.
- Göz ovulmamalıdır.
- Çıkmıyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.



- ***Bir cisim batması varsa ya da metal cisim kaçmışsa;***
- Gereksizce hasta yerinden oynatılmaz.
- Göze hiçbir şekilde dokunulmaz.
- Tıbbi yardım istenir (112).
- Hastanın göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.



Kulađa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım

- Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez
- Su değdirilmez,
- Tıbbi yardım istenir (Ambulans Tel: 112).



Buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım

B
e
l
i
r
t
i
l
e
r

- *Tıkanıklık hissi (nefes almada zorluk)
- *Şişme
- *Burun deliğinden genellikle kanlı akıntı.



- Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.
- Çıkmazsa tıbbi yardım istenir



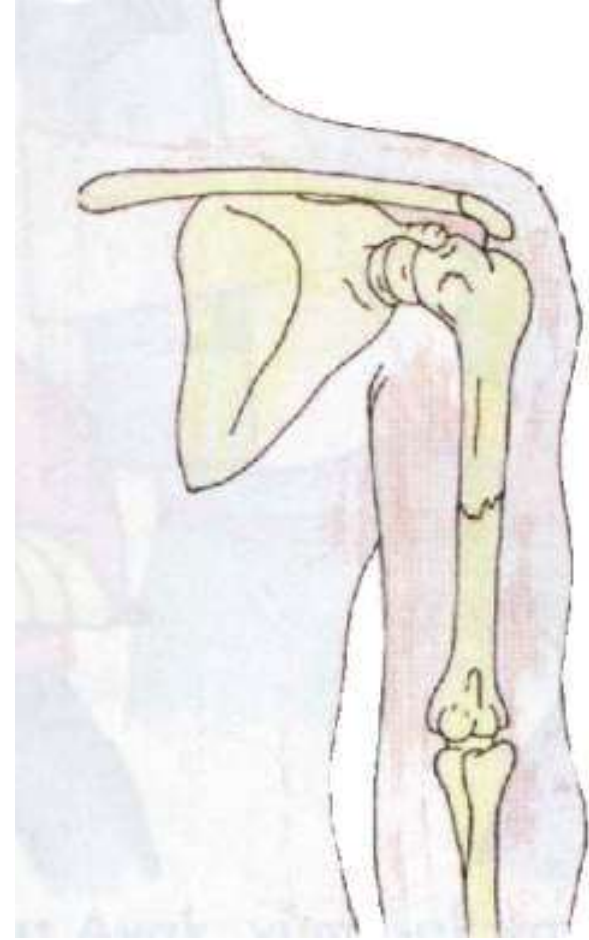
DÜŞME VE ÇARPMALARDA YAPILACAK İLK MÜDAHALE

- Kazazedenin şuuru yerindeyse
Normal hareket ediyorsa  24 saat
Gözleyin
- Kusma / Dalgınlık / Sürekli uyku hali olursa
Sağlık kuruluşuna götürün
- Yüksekten düşmelerde iç kanama olabilir
- Vücutta şişlik / morluk oluşmuşsa
üzerine buz veya soğuk bez koyun

BURKULMA KIRIK VE ÇIKIKLAR



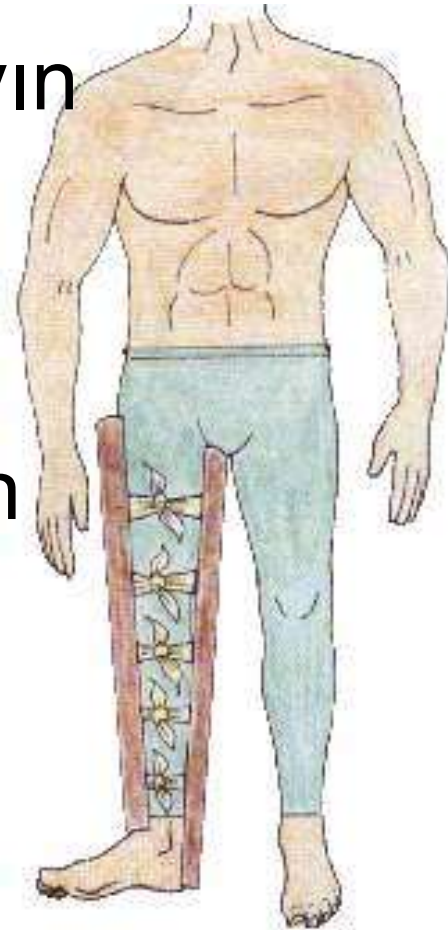
Açık Kırık



Kapalı Kırık

BURKULMA KIRIK VE ÇIKIKLARDA YAPILACAK İLK MÜDAHALE

- Kırık ihtimali varsa
- Kazazedenin elbiselerini çıkarmayın
- Gerekirse keserek çıkarın
- Şüpheli bölgenin altına tahta koyun
- Burkulan eklemi yukarı kaldırın üzerine torba ile buz koyun.



- Çıkıkları kendiniz yerine koymaya çalışmayın
- Her burkulmada kırık da olabileceğini unutmayın
- Açık kırık üzerinde kemik parçaları varsa almayın

- **Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir, düzeltilmeye çalışılmamalıdır.**

Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.

➤ Kırığa yapılacak yanlış müdahale

- * Kemiğin eğri olarak kaynamasına
- * Kısmi felçlere
- * Gangren ve sonuçta kırık organın kesilmesine yol açabilir

En kısa sürede **SAĞLIK KURULUŞUNA** gönderin



Bacağın Tespiti



Bacağın Sarılması ve Kalp Seviyesinden Yukarı Kaldırılması



Basit Tespit Yöntemleri

Kol ceketinin ucu, karşı yakasına iğnelenebilir

Kravat ya da kemer ile boyuna asılabilir

Gazete, mukavva ile tespit edilebilir

Süeter, ön kol üzerine çekilip diğer kolla destek verilebilir





BAYILMA VE İLK YARDIM

Aniden ortaya çıkan dolaşım yetmezliğine bağlı olarak, beynin kısa süreli kansız kalması sonucu görülen geçici bilinç kaybıdır

Nedeni;

- açlık,
- kan basıncının düşmesi
- beklenmedik bir olay veya herhangi bir şeyle karşılaşma
- aşırı sevinç ya da üzüntü,
- uzun süre havasız ve kapalı ortamda bulunma,
- kalp yetmezliği,
- enfeksiyon vb, olabilir.

Belirtileri

- *Halsizlik, baş dönmesi**
- * Bacaklarda uyuşma**
- * Yüz solgunluğu, üşüme ve terleme**
- * Hızlı ve zayıf nabız (Bazen bilek atardamarından nabız alınamaz.)**
- * Düşme sonucunda oluşan başka yaralanmalar**

BAZI DURUMLARDA BAYILMA OLMADAN ÖNLEM ALMAK MÜMKÜN OLABİLİR.

Hasta/yaralı bayılma belirtilerini hissederse ;

- Başı eğik olarak oturtulmalı veya sırt üstü yatırılmalı ve beyne giden kan akışını – dolayısı ile oksijen akışının – desteklemek amacıyla ayakları 30 cm. kaldırılmalıdır.
- Hasta/yaralıya rahatsızlık veren giysiler gevşetilmelidir.
- Kendisini daha iyi hissedene kadar dinlenmesi sağlanmalıdır.

Hasta/yaralı bayıldıysa;



- **Beyne giden kan akışını desteklemek amacıyla ayakları 30 cm. kaldırılmalıdır.**
- **Solunum yolu açılmalı ve hasta/yaralı kendine gelene kadar bu açıklık korunmalıdır.**
- **Rahatsız eden giysileri çıkartılmalıdır**

- Kusması durumunda, yan yatırılmalı ve nefesinin normal olup olmadığına bakılmalıdır.
- Hasta/yaralıda ilk yardımı gerektiren diğer durumların (kanama,kırık, çıkık vb.) olup olmadığı kontrol edilmeli, varsa önlemler alınmalıdır.
- Hasta/yaralı yalnız bırakılmamalıdır.

- **Hasta/yaralı hızla kendine gelemiyorsa, solunum yolu açık tutularak en kısa sürede hastaneye ulaştırılmalıdır.**
- **Bayılan kişiye yiyecek, içecek verilmemeli, soğuk su dökülmemeli, tokat atılmamalıdır.**

SARA (EPİLEPSİ NÖBETİ)

Büyük sara(epilepsi) Nöbeti



Beynin elektriksel aktivitesinin aksaması ile oluşur.

SARA (EPİLEPSİ NÖBETİ)

BELİRTİLERİ

Nöbet sırasında

- Hasta aniden bilincini yitirip yere düşer.
- Kısa bir süre için kaskatı kesilir, solunum yavaşlayabilir.
- Ağız ve dudakları morarır.
- Gevşemeye başlayınca çırpınma ve sarsılmalar olur.
- Çene kilitlenir, solunum güçleşir, ağızda köpükler birikir.
- Hasta dilini veya dudağını ısırılmışsa ağızdan kan gelebilir.
- İdrarını ve bazen büyük abdestini kontrol edemeyebilir.

Nöbet sonrasında

- Solunum normale döner.
- Sendeleme ve garip davranışlar görülebilir.
- Hasta dinlenmek ister.

Yapılması gerekenler



- Hastayı rahat edeceği uygun bir yere yatırın
- Dilini ısırması için ağzına mendil sıkıştırın
- Başını vurmaması için yumuşak bir şey ile destekleyin
- Yardımcı olabileceklerin dışındakileri uzaklaştırın
- Giysilerini gevşetip rahatlatın
- Nöbeti geçip hasta tamamen kendine gelinceye kadar hastayı yalnız bırakmayın

Yapılmaması gerekenler



- Tehlike yok ise hastayı kaldırmayın hareket ettirmeyin
- Yiyecek, içecek vermeyin
- Sara nöbeti geçiren hastaların kasılmalarına engel olmaya, çenesini açmaya ve onu uyandırmaya çalışmayın!

Unutmayın ki her nöbet mutlaka durur. !!

EPİLEPTİK NÖBET GEÇİREN HASTAYA YAKLAŞIM

NÖBET SÜRESİNİ
TUT

TUTMA
VE
SARILMA

ÇEVREDEKİLERE
BİLGİ VER

ÇEVREDEKİLERİ
ENGELLE

SAKİN
KONUŞ

NÖBET
GEÇİRİYOR

SAKİN OL



**SARA KRİZİ GEÇİREN KİŞİNİN ELLERİNİ
VE AYAKLARINI BAĞLAMAYIN, SU
İÇİRMeye ÇALIŞMAYIN, ÇENESİNİ
AÇMAYA ÇALIŞMAYIN!**

TEŞEKKÜRLER